

FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA

HISTORIA CLÍNICA - DOCUMENTO SINTÉTICO PARA HOL

Atención en Urgencias - Servicio de Cardiología

Paciente:	Carlos Andrés Suárez Mendoza	Edad:	58 años
Género:	Masculino	Fecha:	2026-05-12

Motivo de consulta

Dolor torácico opresivo de inicio súbito hace 2 horas, irradiado a brazo izquierdo, asociado a diaforesis y náuseas.

Anamnesis (subjeto)

Antecedente de HTA de 10 años, dislipidemia, fumador 20 paquetes-año. Padre con IAM a los 60. Niega alergias.

Examen físico

TA 150/95 mmHg, FC 102 lpm, sat O2 94% aire ambiente, FR 22 rpm, T 36.8 °C. Paciente diaforético, pálido. Ruidos cardíacos rítmicos sin soplos. Pulmones limpios. EKG: depresión del ST en cara inferior.

Diagnóstico principal

Síndrome coronario agudo SCASEST - alta probabilidad. Troponina I inicial 0.08 ng/mL (elevada).

Plan terapéutico

Hospitalización en UCI coronaria. ASA 300mg dosis carga + 100mg/día. Clopidogrel 600mg carga. Atorvastatina 80mg. Heparina enoxaparina 1mg/kg cada 12h. Coronariografía urgente. Monitoreo continuo. NPO.